MODUL NARKOTIKA

A. Mengenal Narkotika

1. Apa itu narkotika?

   Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintesis (buatan) maupun semi sintesis. Zat ini memiliki efek khusus yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa pada tubuh, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang sangat kuat bagi orang yang menggunakannya.

2. Jenis dan golongan

   Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan. Penggolongan ini didasarkan pada seberapa kuat zat tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan (kecanduan) serta apakah zat itu boleh digunakan untuk keperluan medis atau pengobatan:

   1) Golongan I

      Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang memiliki daya ketergantungan sangat kuat dan dinilai sangat berbahaya. Oleh karena itu, undang-undang melarang keras penggunaan golongan ini untuk terapi atau pengobatan medis biasa, dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh tanaman alam yang masuk dalam kelompok ini adalah tanaman ganja, tanaman koka (bahan pembuat kokain), serta tanaman Papaver Somniferum (penghasil opium mentah). Selain tanaman, ada juga zat hasil olahan atau buatan kimiawi yang masuk golongan ini, seperti heroina (yang akrab disebut putaw), metamfetamina (sabu-shabu), dan MDMA (ekstasi).

   2) Golongan II

      Narkotika Golongan II adalah jenis zat yang memiliki daya ketergantungan kuat, namun sangat berkhasiat dan diizinkan untuk digunakan dalam dunia

pengobatan atau pelayanan kesehatan. Karena efek ketergantungannya yang tinggi, penggunaan zat ini sangat diawasi ketat dan membutuhkan resep dokter. Dokter biasanya hanya memberikan obat golongan ini sebagai pilihan untuk meredakan rasa sakit yang sangat hebat. Contoh zat golongan ini adalah morfina (morphine), petidina, dan metadona. Di rumah sakit, morfina dapat digunakan untuk membantu pasien agar terhindar dari rasa nyeri yang luar biasa setelah menjalani operasi besar.

3) Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya ketergantungan lebih ringan dibandingkan golongan I maupun golongan II, serta memiliki manfaat yang sangat luas dalam pengobatan medis. Contoh yang paling sering ditemui adalah kodeina (codeine). Di bawah pengawasan dokter, kodeina ini sering digunakan dalam obat medis seperti pereda nyeri atau pereda batuk khusus karena kemampuannya yang sangat baik untuk mengurangi rasa sakit tanpa memicu kecanduan separah golongan lainnya.

B. Pahami

Cara kerja narkotika di dalam tubuh manusia berpusat pada gangguan terhadap sistem saraf pusat atau otak. Ketika narkotika masuk ke dalam tubuh, zat kimia ini mengacaukan sistem neuro-transmitter, yaitu zat alami penghantar sinyal komunikasi antar sel otak. Kerusakan sinyal ini berdampak langsung pada tiga fungsi penting manusia, yaitu fungsi kognitif (proses berpikir), afektif (alam perasaan dan emosi), serta psikomotor (perilaku).

Setiap jenis narkotika mempunyai cara khusus saat memengaruhi kerja otak. Zat yang bersifat depresan (seperti morfin, heroin, dan alkohol) bekerja menekan atau memperlambat aktivitas otak dan tubuh, sehingga penggunanya merasa mengantuk, tenang, serta rasa nyeri atau stresnya hilang. Sebaliknya, zat yang bersifat stimulan (seperti sabu-shabu, ekstasi, dan kokain) merangsang susunan saraf otak secara berlebihan, membuat jantung berdebar lebih cepat, meningkatkan tekanan darah, serta memicu perilaku yang sangat aktif dan tidak bisa diam. Sementara itu, zat yang bersifat halusinogen (seperti ganja

dan jamur psilocybin) bereaksi pada reseptor di area otak tertentu, seperti area hipokampus yang mengatur daya ingat dan emosi, sehingga mengacaukan panca indera dan memicu khayalan.

Penggunaan narkotika secara berulang akan memaksa sel-sel otak tergantung pada zat tersebut agar bisa berfungsi normal. Kondisi ini memicu toleransi, yaitu keadaan saat tubuh menuntut dosis zat yang semakin tinggi demi mendapatkan efek rasa gembira yang sama. Jika penggunaan zat tiba-tiba dihentikan, pengguna akan mengalami reaksi penolakan tubuh atau gejala putus zat yang sangat menyiksa, yang dalam istilah awam disebut ”sakaw”.

C. Dampak narkotika

1) Dampak fisik

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak fisik yang sangat fatal dan merusak organ-organ tubuh. Dalam jangka panjang, zat beracun ini merusak organ vital seperti otak, paru-paru, hati, ginjal, serta jantung. Pengguna juga akan kehilangan nafsu makan secara drastis sehingga tubuh menjadi sangat kurus, pucat, kurang gizi, dan wajah tampak kuyu.

2) Dampak psikologis

Secara psikologis, narkotika mengacak-acak emosi, pikiran, dan kesadaran penggunanya. Pengguna sering mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, seperti rasa senang berlebihan tanpa sebab (euforia) yang bisa berubah mendadak menjadi kemurungan, rasa panik, cemas berlebihan, dan depresi berat. Dampak kejiwaan yang sangat berbahaya adalah timbulnya halusinasi (melihat atau mendengar hal-hal yang tidak nyata) dan delusi atau waham (keyakinan tidak rasional, seperti rasa curiga berlebihan/paranoid bahwa ada orang yang ingin mencelakakannya). Kerusakan fungsi berpikir ini membuat pengguna sulit berkonsentrasi, mengalami hilang ingatan sementara, dan kehilangan daya dalam menilai kenyataan. Pada tingkat yang parah, narkotika dapat memicu gangguan

jiwa berat yang menyerupai skizofrenia serta dorongan kuat untuk melakukan tindakan bunuh diri.

3) Dampak sosial

Dari aspek sosial, penyalahgunaan narkotika menghancurkan hubungan individu dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kerusakan kontrol diri mengubah perilaku menjadi antisosial dan mudah marah, kasar, serta sering terlibat perkelahian atau tindak kekerasan. Di lingkungan sekolah atau pekerjaan, konsentrasi yang rusak membuat prestasi merosot tajam, sering bolos, hingga berujung pada keputusan dikeluarkan dari sekolah (drop out) atau pemecatan. Rasa kecanduan dan siksaan sakaw juga memaksa pengguna melakukan kebohongan dan aksi kriminal, seperti mencuri barang milik orang tua, menggadaikan harta benda, hingga terlibat pelacuran demi membeli zat narkotika. Pada akhirnya, kondisi ini merusak keharmonisan rumah tangga, mengganggu ketertiban umum, serta merusak tatanan dan masa depan generasi bangsa.

D. Waspadai

Penyalahgunaan narkotika tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipicu oleh gabungan berbagai faktor risiko yang saling berkaitan, baik dari dalam diri seseorang (faktor individu dan kejiwaan) maupun dari lingkungan tempat ia tumbuh dan bergaul (keluarga, pertemanan, dan masyarakat):

1) Faktor dalam diri sendiri (pribadi dan psikologis), kondisi kejiwaan dan corak kepribadian yang rawan menjadi pemicu utama seseorang terjerat narkotika. Orang yang memiliki gangguan kepribadian, rasa cemas berlebihan, atau depresi berat mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi karena mereka kerap mencoba ”mengobati diri sendiri” (self-medication) menggunakan obat terlarang demi menghilangkan rasa takut, sedih, atau tekanan batin. Selain itu, ketidakmampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup (coping mechanism yang buruk), dorongan emosi yang tidak terkendali (impulsif), rasa rendah diri, hingga sekadar rasa ingin tahu, ikut-ikutan, atau pelarian dari rasa kecewa juga mendorong

seseorang untuk mulai coba-coba.ariaktor lingkungan keluarga, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis atau mengalami gangguan (disfungsi keluarga) memperbesar risiko anak terjerumus ke dalam bahaya narkotika. Masalah-masalah dalam keluarga seperti perceraian orang tua (broken home), suasana rumah yang dingin tanpa kehangatan, rumah tangga yang penuh ketegangan, orang tua yang terlalu sibuk dan jarang berada di rumah, serta komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak menjadi penyebab utama. Kurangnya perhatian di rumah membuat anak merasa kesepian sehingga mencari pelarian dan rasa nyaman di luar. Di samping itu, lemahnya penanaman nilai-nilai agama dan panduan moral di dalam keluarga membuat benteng pertahanan diri seseorang menjadi rapuh saat menghadapi cobaan hidup.

2) Dari faktor pertemanan dan lingkungan masyarakat, pengaruh kelompok teman sebaya (peer group) merupakan salah satu pintu masuk terbesar. Sebagian besar pengguna pertama kali mengenal dan mengonsumsi narkotika karena diajak, dibujuk, atau dipaksa oleh temannya agar bisa diterima dan diakui dalam kelompok pergaulan tersebut. Selain pergaulan, faktor lain seperti tekanan modernisasi dan beban tuntutan prestasi, rasa ketidaktahuan akan bahaya kesehatan dan sanksi hukum, kebiasaan awal merokok sebagai pintu masuk, serta mudahnya mendapatkan zat haram di sekitar lingkungan semakin mempertinggi risiko seseorang menjadi pecandu.

E. Cegah

Pencegahan narkotika melalui ketahanan diri atau kekebalan kepribadian (personality resilience) adalah proses membangun kekuatan dari dalam diri seseorang agar tidak mudah terpengaruh oleh bujukan, tekanan pergaulan, maupun godaan untuk mencoba zat terlarang. Seseorang yang memiliki ketahanan diri yang kokoh tidak akan mudah “melarikan diri” ke narkotika ketika menghadapi masalah hidup, stres, rasa cemas, atau rasa kecewa.

- Langkah pertama dalam membentengi diri adalah dengan memupuk rasa percaya diri dan meningkatkan harga diri (self-esteem). Seseorang perlu menyadari bahwa setiap individu lahir unik, berharga, dan memiliki kelebihan serta potensinya masing-masing. Ketika seseorang belajar berfokus pada kelebihannya, menghargai setiap proses usahanya, dan bangga atas hasil karyanya sendiri, ia tidak akan merasa rendah diri atau membutuhkan pengakuan palsu dari pergaulan yang salah.
- Langkah berikutnya adalah mengembangkan kemampuan menolak dan ketegasan berkata ”tidak”. Sebagian besar perkenalan awal dengan narkotika terjadi karena bujukan atau tawaran dari teman sebaya. Oleh sebab itu, seseorang harus dilatih untuk berani mengambil keputusan yang tegas dalam situasi penawaran, yaitu berani menolak pemberian apa pun dari orang lain yang tidak diketahuinya. Keberanian ini didasari oleh pemahaman yang jelas mengenai fakta, risiko, serta dampak buruk narkotika yang dapat merusak kesehatan tubuh dan menghancurkan masa depan.
- Ketahanan diri juga membutuhkan keterampilan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah (coping mechanism) secara positif. Banyak orang terjerumus ke dalam kecanduan karena mencoba ”mengobati diri sendiri” (self-medication) menggunakan obat terlarang demi meredakan kecemasan, kesedihan, atau tekanan batin. Membangun ketahanan diri berarti belajar melatih kesabaran, mengendalikan emosi, dan mencari solusi yang rasional ketika menemui kesulitan, misalnya dengan bercerita dan berkonsultasi kepada orang tua, guru, atau tenaga profesional.
- Selain itu, ketahanan diri diperkuat dengan menerapkan pola hidup sehat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Mengisi waktu sehari-hari dengan berolahraga, mengembangkan bakat atau keterampilan baru, serta melakukan hobi yang bermanfaat dapat membuat hidup terasa bahagia, menarik, dan penuh arti. Tubuh yang sehat dan jiwa yang bahagia tidak memerlukan obat-obatan terlarang, sehingga biaya dan risiko pengobatan di masa depan dapat dihindari sedini mungkin.
- Pondasi paling mendasar dari ketahanan diri adalah penguatan keimanan dan pendidikan kerohanian (spiritual). Memahami dan menghayati nilai-nilai agama

memberikan pedoman moral yang kuat untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk, serta halal dan haram menurut ajaran agama maupun hukum negara. Ketaatan dalam beribadah secara teratur akan memberikan ketenangan batin serta kekuatan kerohanian yang tinggi bagi seseorang untuk membentengi fisik maupun mentalnya dari segala godaan zat haram.

F. Tangani

Penanganan terhadap penderita atau korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan menyeluruh (holistik) yang mencakup pemulihan fisik, kejiwaan (psikologis), sosial, dan kerohanian (spiritual). Prinsip utama dalam penanganan ini adalah "berobat dan bertobat", di mana berobat bertujuan untuk membersihkan racun narkotika dari dalam tubuh serta menyembuhkan gangguan kesehatan fisik, sedangkan bertobat bertujuan untuk memohon ampun kepada Tuhan serta membangun komitmen diri agar tidak mengulangi perbuatan haram tersebut. Proses penanganan ini secara sistematis meliputi empat tahapan utama:

1. Tahap Detoksifikasi (Pembersihan Racun): Langkah awal ini dilakukan dengan pengawasan dokter untuk menghilangkan racun narkotika dari tubuh dan meredakan rasa sakit akibat sakaw. Metode yang digunakan adalah sistem blok total, yaitu menghentikan pemakaian narkotika secara menyeluruh tanpa memberikan obat pengganti yang bersifat adiktif.
2. Tahap Pasca Detoksifikasi (Pemantapan): Setelah racun dibersihkan, penderita menjalani masa pemantapan di rumah-singgah (transit house) atau wisma rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan pendampingan keluarga.
3. Tahap Rehabilitasi: Penderita kemudian melanjutkan perawatan di pusat rehabilitasi untuk mendapatkan bimbingan kejiwaan, konseling, pendidikan keagamaan, serta pelatihan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat.
4. Tahap Pemeliharaan dan Pemantauan (Pasca Rehabilitasi): Untuk mencegah kekambuhan (relapse), penderita yang telah selesai rehabilitasi wajib mengikuti pemantauan, tes urin berkala, dan pertemuan rutin dalam forum silaturahmi selama dua tahun. Seseorang baru dinyatakan benar-benar sembuh apabila berhasil tidak mengonsumsi narkotika sama sekali selama dua tahun berturut-turut.

G. Aspek Hukum

1. Regulasi

   Landasan hukum utama yang mengatur masalah narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1997) agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dan efektif dalam menghadapi kejahatan peredaran gelap narkotika yang semakin canggih serta berskala internasional.

   Regulasi ini juga melengkapi aturan hukum dengan berbagai sanksi tambahan untuk mencegah celah kejahatan. Seseorang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Pihak yang membujuk, memaksa, atau melibatkan anak di bawah umur dalam kejahatan narkotika diancam hukuman berat mulai dari belasan tahun penjara hingga pidana mati. Jika kejahatan dilakukan oleh korporasi (perusahaan), hukuman dendanya dilipatgandakan 3 kali lipat serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum. Selain itu, seluruh aset dan harta benda hasil kejahatan narkotika disita oleh negara. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, mereka akan dideportasi (diusir) keluar dari wilayah Indonesia setelah selesai menjalani hukuman pidana dan dilarang masuk kembali.

2. Penyalahguna

   Bagi seorang penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk dirinya sendiri, pasal 127 ayat (1) menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun untuk Narkotika Golongan I, paling lama 2 tahun untuk Golongan II, dan paling lama 1 tahun untuk Golongan III. Namun, apabila penyalahguna tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, undang-undang mewajibkannya untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di sisi lain, seseorang yang tanpa hak

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman (seperti sabu atau ekstasi) dijerat dengan pasal 112 yang mengancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun hingga 12 tahun serta denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, bahkan dapat diancam penjara seumur hidup jika barang bukti melebihi 5 gram.

3. Pecandu

   Bagi seorang pecandu, hukum memandangnya sebagai pasien atau korban yang harus mendapatkan pengobatan dan pemulihan, bukan sekadar dihukum penjara. Regulasi mengatur sistem Wajib Lapor melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar pecandu mendapatkan perawatan medis dan sosial. Apabila pecandu yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua atau walinya, maka anak tersebut tidak dituntut pidana. Sebaliknya, orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umur dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan. Bagi pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali masa perawatan dokter di lembaga resmi, ia juga tidak dituntut pidana. Namun, jika pecandu cukup umur sengaja tidak melaporkan dirinya sendiri, ia diancam pidana penjara paling lama 6 bulan, dan pihak keluarga yang sengaja tidak melapor juga dapat dipidana paling lama 3 bulan.

4. Pengedar

   Berbeda dengan perlakuan terhadap korban, hukum memberikan sanksi yang sangat berat hingga ancaman hukuman mati bagi para pengedar dan produsen narkotika. Berdasarkan pasal 114, setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana penjara seumur hidup atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Jika barang bukti melebihi 1 kilogram (atau lebih dari 5 batang pohon) untuk bentuk tanaman, atau melebihi 5 gram untuk bentuk bukan tanaman, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 6 hingga 20 tahun. Sanksi pidana mati atau seumur hidup ini juga berlaku bagi produsen yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika melebihi

batas jumlah tersebut sesuai pasal 113. Adapun bagi pelaku yang berperan ganda sebagai pemakai sekaligus pengedar, ia tetap wajib menjalani terapi dan rehabilitasi, namun proses hukum pidananya terus berjalan.